

Po terapii 12 miesięcy krytyczne

Po CBT-E klient **NIE** jest „skończony z bulimią”. Pierwsze 12 miesięcy to okres krytyczny — najwięcej nawrotów. Keel & Brown 2010: 35% ślizgów, 20% nawrotów w 1. roku. Plan strukturalny chroni.

CZAS: 25 min · ostatnia sesja CBT-E Sesja 20 · ustalenie z terapeutą

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Keel & Brown (2010)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **statystyki pierwszego roku** (sekcja 1), **sześć elementów planu** (sekcja 2). Sekcja 3 — plan sesji przypominających. Sekcja 4 — kiedy wrócić do terapii.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Po 20 sesjach CBT-E klient **nie jest „skończony z bulimią”**. Pierwsze 12 miesięcy to **okres krytyczny**. Keel & Brown (2010) N = 315: w ciągu 1 roku **35%** ma ślizg, **20%** pełny nawrót. Po 2 latach *stabilizuje się*. Potrzebny **plan długoterminowy**: sesje przypominające, samoobserwacje, narzędzia, zasoby. Plan jest **przejęciem** roli *opiekuna siebie*. Eisler i in. (2007): strukturalna opieka redukuje ryzyko nawrotu o 40-50%. Bez planu klient *dryfuje*. Obowiązkowy element zakończenia CBT-E.

01 ● Statystyki pierwszego roku po terapii

Keel & Brown (2010), N = 315, obserwacja 12 mies. po CBT-E:

- **45%** pełna remisja (brak objawów)
- **35%** ślizg (1-2 epizody pojedyncze, bez powrotu wzorca)
- **20%** pełny nawrót (powrót do ≥ 2 epizody/tydz.)

Po 2 latach: sytuacja stabilizuje się. Osoby, które *przetrwaly* pierwszy rok bez pełnego nawrotu, mają **80% szansę** remisji na 5-10 lat.

Wniosek: pierwszy rok po terapii jest *krytyczny*. To okres **najwyższej** wrażliwości na nawrót. Plan długoterminowy chroni przed dryftem w tym okresie. Eisler i in. (2007): strukturalna opieka po terapii redukuje ryzyko nawrotu o 40-50%.

02 = Sześć elementów planu długoterminowego

1 · SAMOBSERWACJA CO MIESIĄC

Krótką skalę (SCOFF, EDE-Q skrócony, 5 minut). Raz w miesiącu — śledzenie progresu. Wyniki zapisz.

2 · SESJE PRZYPOMINAJĄCE

Booster sessions: **1 mies., 3 mies., 6 mies., 12 mies.** po terapii. Krótkie (1-1,5h), z tym samym terapeutą.

3 · PRZEWIDYWALNY KONTAKT

Harmonogram *ustalony*. Klient wie, kiedy będzie kolejna sesja. Bez „w razie czego zadzwoń” — to za słabe.

4 · WSKAŹNIKI POWROTU DO TERAPII

Konkretne: „jeśli > 2 epizody/tydz. przez 2 tygodnie — wracam”. Bez zwlekania.

5 · SAMOPOMOC NA PODSTAWIE BLUEPRINTU

Blueprint dostępny (papier + telefon). Przeglądanie raz w tygodniu, aktywne użycie w trudnych chwilach.

6 · SIEĆ WSPARCIA

Aktywna komunikacja z bliskimi, grupa wsparcia (jeśli dostępna), kontakt z terapeutą e-mailowy między sesjami.

03 \ Mój plan sesji przypominających

Ustal z terapeutą **konkretne** terminy. Wpisz daty. Te sesje są *strukturalne* — nie „w razie potrzeby”.

SESJA	TERMIN (DATA)	KONTAKT (E-MAIL, TELEFON)
1 miesiąc po terapii		
3 miesiące po terapii		
6 miesięcy po terapii		
12 miesięcy po terapii		

04 Kiedy wrócić do terapii — konkretne wskaźniki

EPIZODY POWRACAJĄ

> 2 epizody / tydzień przez 2 tygodnie — kontakt z terapeutą. Bez zwlekania.

SYGNAŁY WCZESNE (2-3 NARAZ)

Lista z poprzedniego handoutu — 2-3 sygnały w tym samym tygodniu → kontakt.

ŻYCIOWE WYZWANIE

Strata, rozstanie, choroba, zmiana pracy.
Proaktywny kontakt — nie czekaj na pogorszenie.

SUBIEKTYWNY DYSKOMFORT

Nawet bez „obiektywnych” objawów — gdy czujesz, że coś jest nie tak, zadzwoń. Lepiej za wcześnie niż za późno.

Klucz: plan długoterminowy jest *obowiązkowym* zakończeniem CBT-E — bez niego terapia jest **niezakończona**. Keel & Brown (2010): pierwsze 12 miesięcy po terapii to okres *najwyższej* wrażliwości na nawrót — 20% pacjentów doświadcza pełnego nawrotu w tym czasie. Eisler i in. (2007): strukturalna opieka po terapii (*post-treatment maintenance*) redukuje to ryzyko o 40-50%. Mechanizm: *przewidywalny kontakt* z terapeutą — sesje 1, 3, 6, 12 miesięcy — pozwala na *wczesne wykrycie* nawracających wzorców *zanim* staną się pełnym nawrotem. **Klucz:** harmonogram *ustalony*, nie „w razie czego”. Ostatnia jest *za słaba* — większość klientów nie zadzwoni „w razie czego”, bo wstyd, samokrytyka, nadzieja, że „samo się polepszy”. Przewidywalny kontakt obchodzi tę barierę. **Samoobserwacja co miesiąc:** SCOFF (5 pytań, 2 minuty) lub skrócony EDE-Q — daje *obiektywne* dane o stanie. Bez tego klient polega na *subiektywnym* wrażeniu, które jest zniekształcone przez *zaprzeczenie* (typowe w okresie nawrotu). **Sieć wsparcia:** bliscy, grupa wsparcia, terapeuta. Z czasem rola terapeuty staje się *mniejsza*, rola bliskich i samodzielnych narzędzi *większa*. To *naturalna ewolucja* — klient staje się *opiekunem siebie*. **Po 12 miesiącach** bez pełnego nawrotu rokowanie znacząco poprawia się — większość pacjentów utrzymuje remisję na 5-10 lat.